

10 腫瘍随伴症候群 paraneoplastic syndrome

到達目標

- 胸部腫瘍に合併する腫瘍随伴症候群を列挙できる
- 腫瘍随伴症候群の病因と診断方法を述べ、列挙できる
- 各腫瘍随伴症候群に対する治療方法について述べる

定義

腫瘍随伴症候群とは「原発腫瘍やその転移巣から離れた部位に生じる宿主の臓器障害」と定義される。肺癌における腫瘍随伴症候群合併頻度は10～20%で、組織型別では小細胞癌約50%、非小細胞癌約10%と報告されている。

病態・分類

腫瘍随伴症候群の原因としては、①腫瘍が産生するサイトカイン、ホルモンや機能的蛋白などの生理活性物質による作用、②腫瘍と正常細胞との間に形成された免疫交差反応（immune cross-reactivity）③腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor- α : TNF- α ）などの腫瘍細胞壊死に関与するメディエーターによる場合がある。発熱・食欲不振や悪液質のような全身性の症候のほか、病態や障害される臓器の違いから①内分泌腫瘍随伴症候群、②傍腫瘍性神経症候群（paraneoplastic neurological syndrome: PNS）、③粘膜皮膚腫瘍随伴症候群、④リウマチ性腫瘍随伴症候群、⑤血液腫瘍随伴症候群、⑥腎性腫瘍随伴症候群、⑦凝固系腫瘍随伴症候群などに分類される。

表1に肺癌に合併する頻度の高い病態を示す。臨床的意義は大まかに以下の3点に要約できる。①腫瘍随伴症候群による症状や臓器障害を転移による症状と混同し、結果的に病期や治療法の判断を誤ることがあ

る。②傍腫瘍性神経症候群においては腫瘍発見以前に神経症状が出現し、腫瘍発見の手掛かりとなる。③機序を解明することで腫瘍に対する新たな生物学的解析が可能となる。

診断・治療

腫瘍随伴症候群の治療は原則として腫瘍そのものの除去であるが、除去できない場合や除去後にも症状が改善しない場合もある。そのため、原疾患に対する治療を行いながら対症療法を行うことが基本である。

以下、代表的な腫瘍随伴症候群を取り上げ、その診断と治療法を解説する。

a 内分泌腫瘍随伴症候群

i) ADH不適切分泌症候群(syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: SIADH)

SIADHは肺小細胞がんの10～45%に合併する。腫瘍細胞からADHが持続的に分泌されるため体液貯留と希釈性の低Na血症をきたす。臨床症状は低Na血症に起因する。軽症の場合は悪心・食欲不振程度であるが、急激に血清Na値が低下した場合や重症では痙攣や意識障害をきたす。

診断には以下の点が重要である。①血清Naが135 mEq/L以下、②脱水や浮腫を認めない、③血漿浸透圧が240 mOsm/kg以下、④尿浸透圧が異常上昇(300 mOsm/kg以上)、⑤尿中Na濃度が20 mEq/L以上、⑥血漿バソプレシンが測定感度以上、⑦腎・副腎機能障害を認めない。以上所見を満たせば確定診断となる。

治療法はまず、①水制限を行う、②食塩投与、③選択的バソプレシン受容体拮抗薬を投与する。

治療法はまず、水分制限を行う(1日1,000 mL以下、食事以外では500 mL以下)次に食塩経口あるいは

表1 胸部腫瘍に合併する腫瘍随伴症候群

1. 内分泌 ADH不適切分泌症候群 高Ca血症 Cushing症候群 カルチノイド症候群 高血圧	3. 粘膜・皮膚 皮膚筋炎 肺性肥大性骨関節症 Bazex症候群
2. 神経 辺縁系脳炎 Lambert-Eaton筋無力症候群 脳脊髄炎 亜急性小脳変性症 亜急性感覚性ニューロパチー 眼球クローヌス オブソクローヌス・ミオクローヌス stiff-person症候群	4. リウマチ性疾患 5. 血液 赤芽球癆 白血球・好酸球・血小板増多症 6. 腎臓 膜性腎症 ネフローゼ症候群 7. 凝固系 血栓性静脈炎 播種性血管内凝固症候群